

권 고

1. 제 목 : **금남인력 운영에 관한 사항**

2. 관계기관 : **가나마바병원**

3. 내 용

가. 업무개요

가나마바병원에서는 입원환자 **㉔㉕**품질 제고를 위해 일반병동은 **금남관리료** 차등제 적용하여 적정 **금남인력**을 배치 운영하고 있으며, 국민**㉖㉗**보험공단으로부터 **금남·㉘㉙**서비스 제공기관으로 지정받아 지역사회에 공공**㉚㉛**기관 역할을 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

가나마바병원에서는 의대정원 확대에 따른 전공의 사직으로 인한 입원환자 감소로 인하여 2024년 제3차 병원운영위원회를 개최하여 효율적 병상 운영을 위해 '24.4.1.부터 일부병동을 통합 및 운영병상을 조정하여 축소 운영 중에 있으며, '24.5.16. 기준 #병상을 운영하고 있습니다.

또한, 보건복지부 「고시 제2023-235호」 제3차 상대가치 개편에 따라 일반 병동·중환자실 입원환자 **금남관리료** 차등제를 기존 요양기관의 소재지에 따라 '병상수', '환자수'로 나누어 등급을 산정하였으나 2024.1.부터 소재지와 상관없이 '환자수'를 적용으로 변경되었으며 이에 따른 **가나마바병원** 분기별 **금남관리료** 차등제 등급 내역은 아래 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 가나바병원 분기별 금남관리료 차등제 등급

따라서 가나바병원에서는 병상 축소 등에 따른 비상경영체제에 맞게 한정된 금남인력을 효율적으로 배치함으로써 적정한 금남 등급을 유지하고, 병원경영에 도움이 될 수 있도록 합리적 운영을 고려해야 함이 타당합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 가나바병원의 병상 축소에 따른 금남인력 운영 실태를 확인하여 보니, 금남본부에서는 병동 축소 및 통폐합에 따라 금남인력을 재배치 운영하기 위해 금남사 #명을 진료지원 ㉠ 금남사 #명, ㉡금남사 #명 추가, 금남관리료 차등제 기준 일반병동은 #등급, ㉢㉣병동은 #등급, 금남㉤㉥서비스 병동은 #(금남사당 환자수)로 운영을 위하여 #개 병동 및 ㉦㉧로 #명의 금남사를 재배치하였으나,

PA[공공]사의 경우 '24.4.이전까지 원내 전담[공공]사 #명을 운영하고 있었으며, 전공의 파업에 따라 #개 진료과에서 #명을 추가 배치 요청하였음에도 원내에서 PA [공공]사 업무를 선호하지 않아 '24.8.까지 #명만을 배치한 이후 추가 지원자가 없어 현재까지 채용공고를 진행하고 있어 병동 미운영에 따른 유효 [공공]인력을 추가 배치하지 못하고 있으며,

[공공]A[B]서비스병동의 경우 [표 2]와 같이 미운영 및 축소운영으로 #병상이 감소하였으나, 병상 축소운영에 따른 인력 재배치로 인해 [공공]인력은 '23.10월과 '24.10월 비교 시 병상 축소하였음에도 [공공]인력은 추가되어 운영 중인 것으로 확인됩니다.

[표 2] [공공]A[B]서비스 병동 병상 및 인력 운영현황

그 결과, 위의 [표 2]와 같은 [공공]인력 추가 배치로 분기별 [가나]마[마]병원의 [공공]A[B]서비스 인력 배치 수준은 아래 [표 3]과 같이 [공공]사 # 수준으로 운영하게 되었으며,

[표 3] 분기별 가나마바병원 금남·A·B서비스 인력 배치 수준

국민연금보험공단(이하 '연금공단'이라 한다)으로부터 운영 승인 받은 지정배치 인력기준으로 금남A·B서비스 '금남간병료(금남사#, 금남조무사#) W·W원'으로 수가를 산정하고 있음에도 실질적인 금남A·B서비스 병동 내 금남인력 배치 비율은 위의 [표 2]와 같이 추가 배치하고 있어도 일반병동 금남관리료 차등제와 다르게 연금공단에서 승인받은 지정 배치인력보다 낮은 비율로 운영하고 있어도 '금남간병료(금남사#, 금남조무사#)를 산정하므로 과다 인력 투입에 따른 경영의 효율성은 없는 것으로 확인됩니다.

또한, 금남사 배치수준을 # 이하로 운영하기 위해서는 연금공단으로 금남A·B서비스 운영병동 축소신고 및 연금공단에서 요양기관의 환자중증도, 금남필요도, 진료 특수성(65세 이상 노인환자비율, 수술률, 재원기간) 등을 고려하여 금남사 배치수준의 적정성 여부를 검토 후 #이하 변경 운영이 승인 통보되나,

현재 가나마바병원의 환자분류군별 환자 비율이 종합병원 상향배치(1:8 배치) 기관의 상위환자 적정 비율 기준은 Level¹⁾ 2+3이상 20% 이상이나, [표 4]와 같이 가나마바병원의 24년 1분기 비율은 #%, 2분기 비율은 #% 수준으로 환자의 중증도, 금남필요도가 낮아 지정배치 인력기준을 상향하기 힘든 것으로 확인되어

1) 금남활동과 ADL수준에 따라 금남A·B서비스 입원환자를 5개 그룹(Level 0~3)로 분류, 요양기관의 중증도, 연금공단 요양기관정보마당 내 금남필요도 신고자료를 가지고 그룹별 환자 비율을 산출.

가나마바병원 내 금남A®서비스 환자군의 금남필요도 대비 지정배치 인력 대비
과다한 인력 배치 운영에 대해 재검토가 필요한 것으로 확인됩니다.

[표 4] 가나마바병원 제공인력 배치 적정성 모니터링 결과
<환자분류군별 환자 비율 및 동일 인력배치기관 평균>

(단위:%)

(국민건강보험공단 요양기관정보마당 자료)

*금남A®서비스 금남인력 1:8 배치 운영 중인 종합병원의 평균 환자 분류군 값
종합병원 상향배치(1:8) 기관의 상위환자군 적정 비율 기준은 Level 2+3군 20% 이상

<환자분류군에 따른 금남활동, ADL 점수 비율>

4. 관계기관 의견

가나마바병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○개내마마병원장은

- 병원 경영개선을 위해 []관리료 차등제 등급 상승을 할 수 있는 일반병동, 중환자실 등으로 원내 []인력을 재배치하시기 바라며,(권고)
- 병상 규모대비 과도한 []인력이 투입되었으나 투입대비 병원경영 개선에 실효성 없는 []A②B서비스병동 []인력은 해()공단에서 승인한 기준에 맞게 운영하시기 바랍니다.(권고)